

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Anlage
--	---	----------------------------

Übersicht: Merkmale eines venösen bzw. arteriellen Ulcus cruris		
	Arteriell Ulcus cruris	Venöses Ulcus cruris
Entstehung Ursachen Risiken	Die arteriellen Beingeschwüre entstehen, wenn die Durchblutung eines Körperteils z. B. aufgrund einer Arterienverkalkung erheblich geschwächt worden ist. Risiken hierfür sind: ☐ Rauchen ☐ erhöhter Blutdruck ☐ Diabetes ☐ Gicht ☐ Herz- /Kreislaufkrankungen ☐ Arterienverkalkung der Beine	Die Hauptursache für das Geschwür ist, dass die Klappen des Venensystems, das die oberflächlichen und die tiefen Venen der Beine verbindet, nicht funktionieren. Risiken hierfür sind: ☐ eingeschränktes Venensystem ☐ Beinbrüche oder andere Beinschädigungen ☐ Thrombose in einer tiefen Beinvene ☐ Vorangegangene OP am betroffenen Bein ☐ sitzende o. stehende Tätigkeit ☐ Venenentzündung (Phlebitis) ☐ Übergewicht
Lokalisation	Die Geschwüre kommen meist an den Füßen, Zehen und Fersen vor. Füße und Beine fühlen sich kalt an und sehen evtl. bläulich aus.	Die venösen Beingeschwüre kommen meist im Bereich der Knöchel vor, besonders an der Innenseite des Beins.
Symptome	Die arteriellen Beingeschwüre sind in der Regel schmerzhaft. Die Schmerzen sind am schlimmsten, wenn man ruht, und können besonders in der Nacht sehr stark sein. Den Schmerzen ist abzuweichen, indem man die Unterschenkel u. Füße aus dem Bett hängen lässt, sodass mehr Blut in die Beine fließt u. sie besser durchblutet werden.	Ein Bein mit venösen Problemen ist an seinem charakteristischen Aussehen zu erkennen. Das Bein ist geschwollen. Besonders um bereits bestehende Geschwüre ist die Haut stellenweise bräunlich verfärbt, die Haut ist trocken und juckt (Stasisekzem). Das Geschwür selbst ist oft feucht und nässend, in der Regel aber schmerzlos.
Behandlungsmöglichkeiten laut ärztlicher Anordnung	☐ medikamentöse Therapie ☐ moderne Wundversorgung ☐ Gefäßerweiterung durch operativen Eingriff ☐ Tieflagerung der Beine	☐ Kompressionsverband ☐ moderne Wundversorgung ☐ kontinuierliche Hautpflege ☐ Hochlagerung der Beine ☐ medikamentöse Therapie ☐ evtl. Venenentfernung
Risiko-minimierung	☐ Rauchen einstellen ☐ fettarme Ernährung ☐ viel Obst und Gemüse ☐ Bewegung, auch im Sitzen, z.B. Kreisbewegungen mit den Füßen u. Auf-/Abbewegungen der Fersen ☐ Gewichtsreduzierung bei Übergewicht ☐ passendes Schuhwerk ☐ regelmäßige Untersuchung der Füße und Unterschenkel auf Farbveränderungen und Wunden; dies gilt besonders bei an Diabetes Erkrankten. ☐ Füße warm halten ☐ Verletzungen an Füßen und Unterschenkel vermeiden ☐ regelmäßige Fußpflege	☐ mehr Bewegung ☐ fettarme Ernährung ☐ viel Obst und Gemüse ☐ Gewichtsreduzierung bei Übergewicht ☐ Beine hochlagern ☐ passendes Schuhwerk ☐ regelmäßige Untersuchung der Füße und Unterschenkel auf Farbveränderungen und Wunden; dies gilt besonders bei an Diabetes Erkrankten. ☐ regelmäßige Fußpflege durch Fachpersonal ☐ Übereinanderschlagen der Beine vermeiden ☐ regelmäßige Änderung der Arbeitshaltung
Quelle: pdl.konkret ambulant, Verlag PRO PflegeManagement, www.pflege-management.de, 2010		

	erstellt	überarbeitet	version		Verteiler
Datum	12/2020	01/2026	001	002	Verwaltung/PDL
Unterschrift					

Wundassessment – Dekubitus

Patient/ in

Geburtsdatum

1. Medizinische Wunddiagnose

Grunderkrankungen

Einteilung der Wunde nach EPUAP bzw. der Grunderkrankung

≤ Dekubitus **Kategorie 1** (nicht wegdrückbare Rötung intakter Haut; besonders bei dunkelhäutigen Menschen können auch Hautverfärbungen, Überwärmung, Ödeme oder Verhärtungen Indikatoren für Kategorie 1 sein)

≤ Dekubitus **Kategorie 2** (Teilverlust der Haut, mit: Schädigung von Epidermis, Dermis oder beiden Hautschichten; Dekubitus ist oberflächlich und manifestiert sich klinisch als Hautabschürfung oder Blase)

≤ Dekubitus **Kategorie 3** (Verlust aller Hautschichten einschließlich Schädigung oder Nekrose des subkutanen Gewebes, die bis auf, aber nicht unter die darunterliegende Faszie reichen kann)

≤ Dekubitus **Kategorie 4** (ausgedehnte Zerstörung, Gewebse Nekrose oder Schädigung von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen, mit oder ohne Verlust aller Hautschichten)

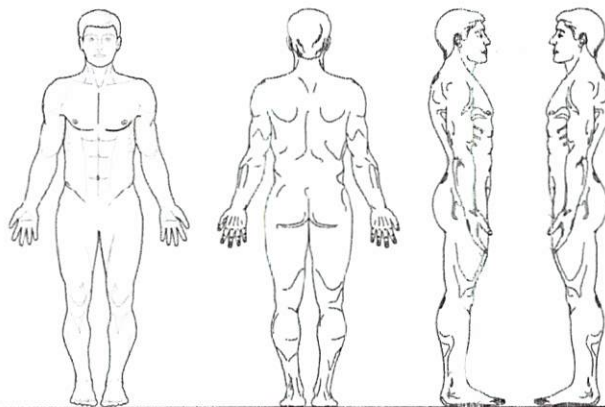
≤ **vollständiger Haut oder Gewebeverlust – unbekannte Tiefe** (tatsächliche Tiefe der Wunde von Belag und Wundkruste/Schorf im Wundbett verdeckt)

≤ **vermutete tiefe Gewebsschädigung – unbekannte Tiefe** (violett oder rötlichbrauner, umschriebener Bereich verfärbter, intakter Haut oder blutgefüllte Blase aufgrund einer Schädigung des darunterliegenden Weichgewebes durch Druck und/oder Scherkräfte)

bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen

2. Wundlokalisation

graphische Dokumentation anhand eines Körperschemas



fachlich korrekte verbale Dokumentation

≤ cranial ≤ dorsal ≤ caudal ≤ plantar ≤ proximal ≤ distal ≤ anterior
≤ posterior ≤ superior ≤ inferior ≤ lateral ≤ medial ≤ ventral

≤

3. Wunddauer

Wunde besteht seit

Entstehungsort:

4. Rezidivzahl

Zahl der Rezidive:

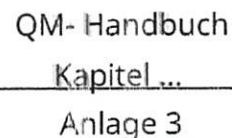
Rezidivfreie Zeit:

Beschreibung

.....



5. Wundgröße									
Länge (in cm)									
Breite (in cm)									
Tiefe (in cm)									
6. Unterminierung									
< ja >									
< nein									
7. Wundgrund/ Gewebeart									
< Granulationsgewebe									
< Fibringewebe									
< Epithelgewebe									
< Nekrose									
< Muskeln									
< Faszie									
< Sehnen									
< Krochen									
< Fettgewebe									
< Dermis									
< Sonstiges									
8. Exsudat/ Transsudat									
Häufigkeit des Verbandswechsels									
Anzahl der durchnässten Kompressen									
< kein: abgeheilt oder trockene Wunde									
< wenig: Wundbett feucht, Verband trocken									
< gering: Wundbett feucht, etwas aus dem Verband austretend									
< moderat: deutlich flüssig im Wundbett, über 50% d. Verbandes erschöpft									
< serös / blutig (serosanguinös): wässrig, hell rot bis rosa									
< serös: wässrig, klar, hell, gelblich									
< serös / eitrig: undurchsichtig									
< eitrig: undurchsichtig, gelblich bis grün mit faulem / schlechten Geruch									
< Sonstiges									
9. Wundgeruch									
< ja									
< nein									
10. Wundrand									
< intakt									
< nekrotisch									
< Unterminiert									
< wulstig									
< mazeriert									
< rosig									
< Sonstiges									
Rückschluss auf Wundheilungsstörung									
< Bildung von Hyperkeratosen									
< Nekrosen und Einblutungen durch unzureichende Druckentlastung									
< Sonstiges									
11. Wundumgebung									
< intakt									
< gerötet									
< geschwollen									
< mazeriert									
< trocken									
< feucht									
< Wärmeentwicklung									
< die Farbe									
< Rückschluss auf Infektionen									
< Rückschluss auf mangelnde Druckentlastung									
< Rückschluss auf Hautirritationen durch Kompressionsrumpfe									
< Sonstiges									
Protokoll- Version-Nr. 2									
Seite 2 von 3									
Stand									

[illegible]

☐	Dauerhaft (Stärke laut VA§)
☐	Nur beim Verbandswechsel
☒	Schmerztagebuch
☒	Schmerztherapie/-medikation
☐	Sonstiges

[illegible]

≤ Weichlagerung						
≤ Anti- Dekubitus- Matratze; Typ:						
≤ Bewegung (siehe Bewegungsplan)						
≤ Verband						
≤ Sonstiges						

Datum

[illegible]

Wundassessment – Ulcus Cruris venosum

Patient/ in

Geburtsdatum

1. Medizinische Wunddiagnose

Grunderkrankungen

Schweregradeinteilung der Wunde bzw. der Grunderkrankung (der Expertenstandard empfiehlt die Klassifizierung von Widmer)

≤ Stadium 1 (reversible Ödeme; Corona phlebectatica (dunkel-blaue Hautveränderungen am medialen und lateralen Fussrand); perimalleoläre Kollbchenvenen)

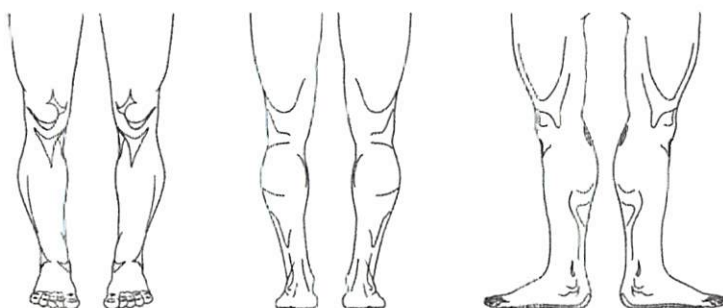
≤ Stadium 2 (persistierende Ödeme; Hämosiderose und Purpura der Haut im Unterschenkelbereich; Dermatosklerosen und Lipodermatosklerose; Atrophie blanche; Stauungsekzem; zyanotische Hautfarbe)

≤ Stadium 3 (Ulcer cruris: Unterschenkelgeschwür oder Ulkusnarbe)

bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen

2. Wundlokalisation

graphische Dokumentation anhand eines Körperschemas



fachlich korrekte verbale Dokumentation

≤ cranial ≤ dorsal ≤ caudal ≤ plantar ≤ proximal ≤ distal ≤ anterior
≤ posterior ≤ superior ≤ inferior ≤ lateral ≤ medial ≤ ventral

≤

3. Wunddauer

Wunde besteht seit

Entstehungsort:

4. Rezidivzahl

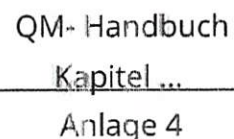
Zahl der Rezidive:

Rezidivfreie Zeit:

Beschreibung

.....
.....
.....
.....

5. Wundgröße									
Länge (in cm)									
Breite (in cm)									
Tiefe (in cm)									
6. Unterminierung									
< ja >									
< nein									
7. Wundgrund/ Gewebeart									
< Granulationsgewebe									
< Fibringewebe									
< Epithelgewebe									
< Nekrose									
< Muskeln									
< Faszie									
< Sehnen									
< Krochen									
< Fettgewebe									
< Dermis									
< Sonstiges									
8. Exsudat/ Transsudat									
Häufigkeit des Verbandswechsels									
Anzahl der durchnässten Kompressen									
< kein: abgeheilt oder trockene Wunde									
< wenig: Wundbett feucht, Verband trocken									
< gering: Wundbett feucht, etwas aus dem Verband austretend									
< moderat: deutlich flüssig im Wundbett, über 50% d. Verbandes erschöpft									
< serös / blutig (serosanguinös): wässrig, hell rot bis rosa									
< serös: wässrig, klar, hell, gelblich									
< serös / eitrig: undurchsichtig									
< eitrig: undurchsichtig, gelblich bis grün mit faulem / schlechten Geruch									
< Sonstiges									
9. Wundgeruch									
< ja									
< nein									
10. Wundrand									
< intakt									
< nekrotisch									
< unterminiert									
< wulstig									
< mazeriert									
< rosig									
< Sonstiges									
Rückschluss auf Wundheilungsstörung									
< Bildung von Hyperkeratosen									
< Nekrosen und Einblutungen durch unzureichende Druckentlastung									
< Sonstiges									
11. Wundumgebung									
< intakt									
< gerötet									
< geschwollen									
< mazeriert									
< trocken									
< feucht									
< Wärmeentwicklung									
< die Farbe									
< Rückschluss auf Infektionen									
< Rückschluss auf mangelnde Druckentlastung									
< Rückschluss auf Hautirritationen durch Kompressionsrumpfe									
< Sonstiges									
Protokoll- Version-Nr. 1									

Stand

Wundassessment – Ulcus Cruris arteriosum

Patient/ in

Geburtsdatum

1. Medizinische Wunddiagnose

Grunderkrankungen

Schweregradeinteilung der Wunde bzw. der Grunderkrankung (der Expertenstandard empfiehlt die Klassifizierung von Fontaine)

≤ Stadium I (symptomlos, evt. leichte Ermüdbarkeit beim Gehen)

≤ Stadium IIa (ab einer Gehstrecke von 200m setzen Schmerzen ein)

≤ Stadium IIb (Schmerzen bei einer Gehstrecke unter 200m)

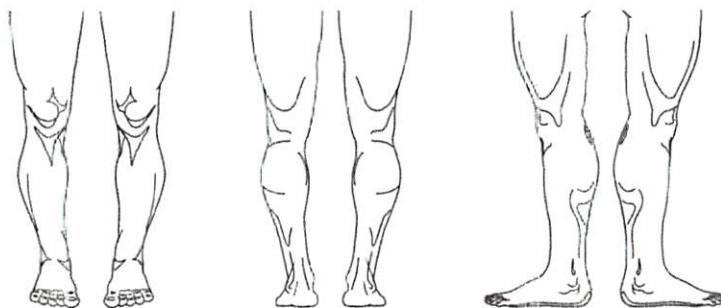
≤ Stadium III (Ruheschmerz)

≤ Stadium IV (Dauerschmerz, Ulcus, Nekrose, Gangrän)

bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen

2. Wundlokalisation

graphische Dokumentation anhand eines Körperschemas



fachlich korrekte verbale Dokumentation

≤ cranial ≤ dorsal ≤ caudal ≤ plantar ≤ proximal ≤ distal ≤ anterior

≤ posterior ≤ superior ≤ inferior ≤ laterial ≤ medial ≤ ventral

≤

3. Wunddauer

Wunde besteht seit

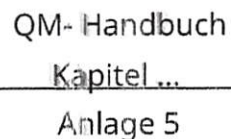
Entstehungsort:

4. Rezidivzahl

Zahl der Rezidive:

Rezidivfreie Zeit:

Beschreibung



5. Wundgröße									
Länge (in cm)									
Breite (in cm)									
Tiefe (in cm)									
6. Unterminierung									
< ja >									
< nein									
7. Wundgrund/ Gewebeart									
< Granulationsgewebe									
< Fibringewebe									
< Epithelgewebe									
< Nekrose									
< Muskeln									
< Faszie									
< Sehnen									
< Krochen									
< Fettgewebe									
< Dermis									
< Sonstiges									
8. Exsudat/ Transsudat									
Häufigkeit des Verbandswechsels									
Anzahl der durchnässten Kompressen									
< kein: abgeheilt oder trockene Wunde									
< wenig: Wundbett feucht, Verband trocken									
< gering: Wundbett feucht, etwas aus dem Verband austretend									
< moderat: deutlich flüssig im Wundbett, über 50% d. Verbandes erschöpft									
< serös / blutig (serosanguinös): wässrig, hell rot bis rosa									
< serös: wässrig, klar, hell, gelblich									
< serös / eitrig: undurchsichtig									
< eitrig: undurchsichtig, gelblich bis grün mit faulem / schlechten Geruch									
< Sonstiges									
9. Wundgeruch									
< ja									
< nein									
10. Wundrand									
< intakt									
< nekrotisch									
< U nterminiert									
< wulstig									
< mazeriert									
< rosig									
< Sonstiges									
Rückschluss auf Wundheilungsstörung									
< Bildung von Hyperkeratosen									
< Nekrosen und Einblutungen durch unzureichende Druckentlastung									
< Sonstiges									
11. Wundumgebung									
< intakt									
< gerötet									
< geschwollen									
< mazeriert									
< trocken									
< feucht									
< Wärmeentwicklung									
< die Farbe									
< Rückschluss auf Infektionen									
< Rückschluss auf mangelnde Druckentlastung									
< Rückschluss auf Hautirritationen durch Kompressionsstrümpfe									
< Sonstiges									
Protokoll- Version-Nr. 1									

Zusatzinstrument „Wittener Aktivitätenkatalog“
BEI VENÖS BEDINGT OFFENEN BEINEN

Patient/ in

Geb.datum

Erhebungsdatum

1 Maßnahmen zur Verhinderung eines Blutstaus in den Beinen

1.1 Maßnahmen zur Kompression

1.1.a allgemein

1. wenn ich ein geschlossenes Bein habe, ziehe ich einen
Kompressionsstrumpf an

2. ich lege den Kompressionsverband/ -strumpf morgens sofort
beim Aufstehen an

3. wenn das Bein vor dem Anlegen der Kompression geschwollen
ist, lege ich das Bein hoch oder dusche ich das Bein kalt ab

4. nach dem Anlegen der Kompression bewege ich mich
mindestens 20 Minuten oder massiere das Bein

5. wenn die Kompression tagsüber zu fest wird, lege ich meine
Beine hoch oder bewege mich

6. ich trage eine Kompression (Verband, Strumpf) jeden Tag

7. ich trage eine Kompression (Verband, Strumpf) nur tagsüber

ja, stimmt
genau (1)

eher
ja (2)

eher
nein (3)

nein, stimmt
nicht (4)

wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten einen Kompressionsverband aus Binden getragen haben, gehen
Sie bitte weiter zu Frage 8

wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten einen Kompressionsstrumpf getragen haben, gehen Sie nun bitte
weiter zu Frage 14

1.1 Maßnahmen zur Kompression

1.1.b Kompressionsverband aus Binden

8. ich lege den Kompressionsverband selber an

9. ich wickle das Bein mit 2 Binden

10. ich polstere die offenen Stellen unter den Binden ab

11. ich wickle die Binden so, dass der Druck vom Fußgelenk zum
Knie hin abnimmt

12. wenn der Kompressionsverband sich lockert, wickle ich das
Bein neu

13. ich Sorge dafür, dass die Binden nicht verrutschen

ja, stimmt
genau (1)

eher
ja (2)

eher
nein (3)

nein, stimmt
nicht (4)

andere Maßnahmen, welche ich durchführe:.....

1.1 Maßnahmen zur Kompression

1.1.c Kompressionsstrümpfe

14. ich ziehe mindestens jeden 2.Tag einen frischen
Kompressionsstrumpf an

15. wenn der Kompressionstrumpf ausleiert, ziehe ich ihn
nicht mehr an

16. ich lasse Sitz / Qualität der Kompressionsstrümpfe mind.
alle 6 Monate von einem Arzt prüfen

17. ich besorge alle 6 Monate neue Kompressionsstrümpfe

ja, stimmt
genau (1)

eher
ja (2)

eher
nein (3)

nein, stimmt
nicht (4)

andere Maßnahmen, welche ich durchführe:.....

Zusatzinstrument „Wittener Aktivitätenkatalog“
BEI VENÖS BEDINGT OFFENEN BEINEN

Patient/ in	Geb.datum	Erhebungsdatum
-------------	-----------	----------------

1 Maßnahmen zur Verhinderung eines Blutstaus in den Beinen				
1.1 Maßnahmen zur Kompression	ja, stimmt genau (1)	eher ja (2)	eher nein (3)	nein, stimmt nicht (4)
1.1.a allgemein				
1. wenn ich ein geschlossenes Bein habe, ziehe ich einen Kompressionsstrumpf an				
2. ich lege den Kompressionsverband/ -strumpf morgens sofort beim Aufstehen an				
3. wenn das Bein vor dem Anlegen der Kompression geschwollen ist, lege ich das Bein hoch oder dusche ich das Bein kalt ab				
4. nach dem Anlegen der Kompression bewege ich mich mindestens 20 Minuten oder massiere das Bein				
5. wenn die Kompression tagsüber zu fest wird, lege ich meine Beine hoch oder bewege mich				
6. ich trage eine Kompression (Verband, Strumpf) jeden Tag				
7. ich trage eine Kompression (Verband, Strumpf) nur tagsüber				

wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten einen Kompressionsverband aus Binden getragen haben, gehen Sie bitte weiter zu Frage 8

wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten einen Kompressionsstrumpf getragen haben, gehen Sie nun bitte weiter zu Frage 14

1.1 Maßnahmen zur Kompression	ja, stimmt genau (1)	eher ja (2)	eher nein (3)	nein, stimmt nicht (4)
1.1.b Kompressionsverband aus Binden				
8. ich lege den Kompressionsverband selber an				
9. ich wickle das Bein mit 2 Binden				
10. ich polstere die offenen Stellen unter den Binden ab				
11. ich wickle die Binden so, dass der Druck vom Fußgelenk zum Knie hin abnimmt				
12. wenn der Kompressionsverband sich lockert, wickle ich das Bein neu				
13. ich Sorge dafür, dass die Binden nicht verrutschen				

andere Maßnahmen, welche ich durchführe:.....

1.1 Maßnahmen zur Kompression	ja, stimmt genau (1)	eher ja (2)	eher nein (3)	nein, stimmt nicht (4)
1.1.c Kompressionsstrümpfe				
14. ich ziehe mindestens jeden 2.Tag einen frischen Kompressionsstrumpf an				
15. wenn der Kompressionstrumpf ausleiert, ziehe ich ihn nicht mehr an				
16. ich lasse Sitz / Qualität der Kompressionsstrümpfe mind. alle 6 Monate von einem Arzt prüfen				
17. ich besorge alle 6 Monate neue Kompressionsstrümpfe				

andere Maßnahmen, welche ich durchführe:.....

Zusatzinstrument „Wound-QoL“
LEBENSQUALITÄTSBOGEN CHRONISCHE WUNDEN

Patient/ in

Geb.

Erhebungsdatum

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
neben der medizinischen Behandlung Ihrer chronischen Wunde möchten wir gern erfahren, wie sehr Ihre Erkrankung Sie in Ihrer persönlichen Lebensführung einschränkt.
Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns im Voraus!

Mit den folgenden Fragen möchten wir erfahren, wie es Ihnen mit Ihrer/Ihren chronischen Wunde(n) geht.
Bitte setzen Sie pro Zeile genau ein Kreuz.

In den letzten 7 Tagen...	Gar nicht	Etwas	Mittelmäßig	Ziemlich	Sehr
1. ...hatte ich Schmerzen in der Wunde					
2. ...hatte ich einen unangenehmen Geruch in der Wunde					
3. ...hatte ich störenden Wundausfluss					
4. ...war mein Schlaf durch die Wunde beeinträchtigt					
5. ...war die Behandlung der Wunde für mich belastend					
6. ...war ich wegen der Wunde niedergeschlagen					
7. ...hat es mich frustriert, dass die Heilung so lange dauert					
8. ...habe ich mir Sorgen wegen meiner Wunde gemacht					
9. ...hatte ich Angst vor einer Verschlechterung oder vor neuen Wunden					
10. ...hatte ich Angst, mich an der Wunde zu stoßen					
11. ...konnte ich mich wegen der Wunde schlecht fortbewegen					
12. ...war das Treppensteigen wegen der Wunde mühsam					
13. ...hatte ich wegen der Wunde Probleme mit Alltagstätigkeiten					
14. ...waren meine Freizeitaktivitäten wegen der Wunde eingeschränkt					
15. ...musste ich wegen der Wunde Aktivitäten mit Anderen einschränken					
16. ...fühlte ich mich wegen der Wunde abhängig von der Hilfe Anderer					
17. ...war die Wunde für mich eine finanzielle Belastung					
Wound-QoL-Gesamtwert					

„Wound-QoL“ Fragebogen zur Lebensqualität bei chronischen Wunden, Augustin et al. 2014, Blome et al. 2014

Auswertung:

- Punkte: 0-gar nicht, 1-etwas, 2-mittelmäßig, 3-ziemlich und 4-sehr
- mindestens 13 von 17 Fragen müssen beantwortet werden
- Summe geteilt durch Anzahl beantworteter Fragen = Wound-QoL-Gesamtwert
- Bereiche in denen der Patient mit ‚ziemlich‘ oder ‚sehr‘ geantwortet hat zeigen Handlungsbedarf auf

C) vorhandene wundbezogene Hilfsmittel

Kompressionsstrümpfe

Orthesen

druckreduzierende Matratzen

D) Selbstmanagementkompetenzen von Patienten und Angehörigen

krankheitsspezifische Maßnahmen

- entstauende Maßnahmen
 - ☐ Kompression (Anziehen, Pflegen, Umgang mit kompressionsbedingten Beschwerden)
 - ☐ Aktivierung des Sprunggelenkes und der Muskelpumpe
 - ☐ Hochlegen der Beine
- Fußpflege und -inspektion
- präventive Maßnahmen bei Diabetischem Fußulcus (z.B. Fußpflege, Umgang mit Schuhen)
- Druckentlastung der Wunde (Hilfsmittel, Bewegungsförderung / Umlagerung)
- Gefäßtraining; Gehtraining

zum Umgang mit Einschränkungen

zur Wunde und Verbandswechsel
(Wundgeruch, Schmerzen)

Erhalt von Alltagsaktivitäten (z.B. Einkaufen, Hobbies)

Hautschutz / Hautpflege

Ernährung

Blutzuckereinstellung

Rauchentwöhnung

wund- und therapiebedingte Einschränkungen

Patient/ in	Geburtsdatum
Diagnose	≤ Ersteinschätzung Datum:..... ≤ Folgeeinschätzung Datum:.....

A) Patienten- / Angehörigenwissen	
zu Ursachen der Wunde	
zur Heilung der Wunde und Vorstellungen zur Wundheilungszeit	
zu Symptomen (z.B. Geruch, Exsudat, Juckreiz)	
zur Bedeutung spezieller Maßnahmen (z.B. Druckentlastung, Bewegung, Kompression)	
B) Wund- und therapiebedingte Einschränkung	
Schmerzen (Stärke, Qualität, Häufigkeit, Dauer, Situationen die mit Schmerzen einhergehen, Ort, Erfahrungen mit Maßnahmen zur Verbesserung der Schmerzen)	
Mobilitäts- und Aktivitätseinschränkungen	
Schlafstörungen	
Abhängigkeit von personeller Hilfe	
Jucken und Schwellen der Beine	
Schwierigkeiten bei Kleidungs- und Schuhwahl	
Schwierigkeiten zur Aufrechterhaltung der persönlichen Hygiene	
psychosoziale Aspekte (z.B. soziale Isolation, Machtlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Depression, Energielosigkeit, Sorgen, Frustration, Mangel an Selbstwertgefühl, Hilflosigkeit, Gefühl des Kontrollverlustes)	

5. Wundgröße									
Länge (in cm)									
Breite (in cm)									
Tiefe (in cm)									
6. Unterminierung									
< ja >									
< nein									
7. Wundgrund/ Gewebeart									
< Granulationsgewebe									
< Fibringewebe									
< Epithelgewebe									
< Nekrose									
< Muskeln									
< Faszie									
< Sehnen									
< Knochen									
< Fettgewebe									
< Dermis									
< Sonstiges									
8. Exsudat/ Transsudat									
Häufigkeit des Verbandwechsels									
Anzahl der durchnässten Kompressen									
< kein: abgeheilt oder trockene Wunde									
< wenig: Wundbett feucht, Verband trocken									
< gering: Wundbett feucht, etwas aus dem Verband austretend									
< moderat: deutlich flüssig im Wundbett, über 50% d. Verbandes erschöpft									
< serös / blutig (serosanguinös): wässrig, hell rot bis rosa									
< serös: wässrig, klar, hell, gelblich									
< serös / eitrig: undurchsichtig									
< eitrig: undurchsichtig, gelblich bis grün mit faulem / schlechten Geruch									
< Sonstiges									
9. Wundgeruch									
< ja									
< nein									
10. Wundrand									
< intakt									
< nekrotisch									
< Unterminiert									
< wulstig									
< mazeriert									
< rosig									
< Sonstiges									
Rückschluss auf Wundheilungsstörung									
< Bildung von Hyperkeratosen									
< Nekrosen und Einblutungen durch unzureichende Druckentlastung									
< Sonstiges									
11. Wundumgebung									
< intakt									
< gerötet									
< geschwollen									
< mazeriert									
< trocken									
< feucht									
< Wärmeentwicklung									
< die Farbe									
< Rückschluss auf Infektionen									
< Rückschluss auf mangelnde Druckentlastung									
< Rückschluss auf Hautirritationen durch Kompressionsstrümpfe									
< Sonstiges									
Protokoll- Version-Nr. 1									

Wundassessment – sekundär heilende Wunden

Patient/ in

Geburtsdatum

1. Medizinische Wunddiagnose

Grunderkrankungen

Art der Wunde / Wundentstehung

≤ Verbrennung

≤ Postoperative Wunde.....

≤ Tumor.....

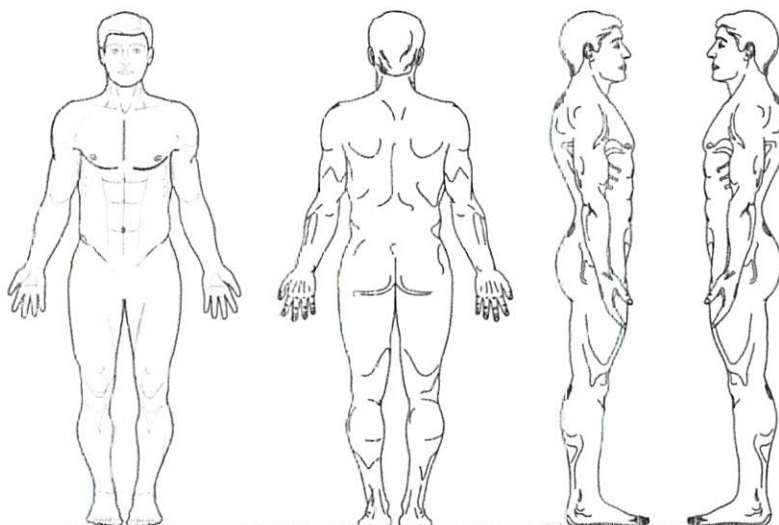
≤ Hautdefekt.....

≤

bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen

2. Wundlokalisierung

graphische Dokumentation anhand eines Körperschemas



fachlich korrekte verbale Dokumentation

≤ cranial ≤ dorsal ≤ caudal ≤ plantar ≤ proximal ≤ distal ≤ anterior

≤ posterior ≤ superior ≤ inferior ≤ lateral ≤ medial ≤ ventral

≤

3. Wunddauer

Wunde besteht seit

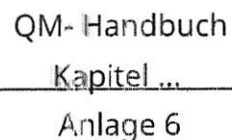
Entstehungsort:

4. Rezidivzahl

Zahl der Rezidive:

Rezidivfreie Zeit:

Beschreibung

[illegible]

5. Wundgröße									
Länge (in cm)									
Breite (in cm)									
Tiefe (in cm)									
6. Unterminierung									
< ja >									
< nein									
7. Wundgrund/ Gewebeart									
< Granulationsgewebe									
< Fibringewebe									
< Epithelgewebe									
< Nekrose									
< Muskeln									
< Faszie									
< Sehnen									
< Knochen									
< Fettgewebe									
< Dermis									
< Sonstiges									
8. Exsudat/ Transsudat									
Häufigkeit des Verbandswechsels									
Anzahl der durchnässten Kompressen									
< kein: abgeheilt oder trockene Wunde									
< wenig: Wundbett feucht, Verband trocken									
< gering: Wundbett feucht, etwas aus dem Verband austretend									
< moderat: deutlich flüssig im Wundbett, über 50% d. Verbandes erschöpft									
< serös / blutig (serosanguinös): wässrig, hell rot bis rosa									
< serös: wässrig, klar, hell, gelblich									
< serös / eitrig: undurchsichtig									
< eitrig: undurchsichtig, gelblich bis grün mit faulem / schlechten Geruch									
< Sonstiges									
9. Wundgeruch									
< ja									
< nein									
10. Wundrand									
< intakt									
< nekrotisch									
< unterminiert									
< wulstig									
< mazeriert									
< rosig									
< Sonstiges									
Rückschluss auf Wundheilungsstörung									
< Bildung von Hyperkeratosen									
< Nekrosen und Einblutungen durch unzureichende Druckentlastung									
< Sonstiges									
11. Wundumgebung									
< intakt									
< gerötet									
< geschwollen									
< mazeriert									
< trocken									
< feucht									
< Wärmeentwicklung									
< die Farbe									
< Rückschluss auf Infektionen									
< Rückschluss auf mangelnde Druckentlastung									
< Rückschluss auf Hautirritationen durch Kompressionsrumpfe									
< Sonstiges									

Wundassessment – Diabetischer Fußulcus

Patient/ in

Geburtsdatum

1. Medizinische Wunddiagnose

Grunderkrankungen

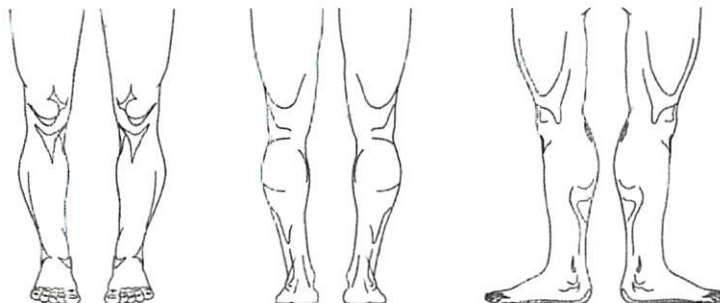
Schweregradeinteilung der Wunde bzw. der Grunderkrankung durch Wagner-Armstrong-Klassifikation

	0	1	2	3	4	5
A	≤ prä- oder post-ulcerative Läsion	≤ oberflächige Wunde	≤ Wunde bis zur Ebene von Sehne oder Kapsel	≤ Wunde bis zur Ebene von Knochen oder Gelenk	≤ Nekrose von Fußteilen	≤ Nekrose des gesamten Fußes
B	≤ mit Infektion	≤ mit Infektion	≤ mit Infektion	≤ mit Infektion	≤ mit Infektion	≤ mit Infektion
C	≤ mit Ischämie	≤ mit Ischämie	≤ mit Ischämie	≤ mit Ischämie	≤ mit Ischämie	≤ mit Ischämie
D	≤ mit Infektion und Ischämie	≤ mit Infektion und Ischämie	≤ mit Infektion und Ischämie	≤ mit Infektion und Ischämie	≤ mit Infektion und Ischämie	≤ mit Infektion und Ischämie

bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen:

2. Wundlokalisierung

graphische Dokumentation anhand eines Körperschemas



fachlich korrekte verbale Dokumentation

≤ cranial ≤ dorsal ≤ caudal ≤ plantar ≤ proximal ≤ distal ≤ anterior
 ≤ posterior ≤ superior ≤ inferior ≤ laterial ≤ medial ≤ ventral

≤

3. Wunddauer

Wunde besteht seit

Entstehungsort:

4. Rezidivzahl

Zahl der Rezidive:

Rezidivfreie Zeit:

Beschreibung

Definition:

Zu den akuten Wunden zählen Mechanische Wunden, Thermische Wunden, iatrogene Wunden und Verletzungen durch Chemikalien. Die Wundheilung verläuft primär und sollte nach ungefähr zwei bis drei Wochen abgeschlossen sein. Treten Komplikationen, wie eine Infektion auf, kann dies die Wundheilung verzögern und eine zusätzliche Therapie erfordern. Bei Wunden mit größerem Gewebsverlust tritt häufig die sekundäre Wundheilung ein. Das bedeutet, dass der Körper das verlorene Gewebe neu bilden muss, weil die Wunde nicht mit Nähten oder Klammern verschlossen werden kann. Dies kann mehrere Wochen oder Monate dauern. Auch akute und infizierte Wunden werden manchmal durch sekundäre Heilung verschlossen. Beispiele hier sind Biss- oder Abszesswunden mit hohem Infektionsrisiko.

Grundsätze:

- Wir betrachten keine Wunde als "hoffnungslos". Selbst bei Hautdefekten mit schlechter Prognose streben wir stets einen Wundverschluss an. Bleibt dieses Ziel unerreichbar, ist selbst ein kleiner Heilungsfortschritt bereits ein Erfolg.
- Jede chronische Wunde ist die Folge einer chronischen Grunderkrankung. Deren Therapie ist Voraussetzung für eine dauerhafte Wundheilung.
- Bei chronischen Wunden gibt es keine allgemeingültigen Behandlungsstrategien. Jeder Betroffene benötigt eine individuell angepasste Vorgehensweise. Wir haben keine Angst vor dem Prinzip "Versuch und Irrtum".
- Wunden sind nicht nur eine körperliche Belastung, sondern beeinträchtigen auch das Selbstwertgefühl eines Pflegebedürftigen. Niemals darf ein Bewohner den Eindruck gewinnen, dass sich die Pflegekraft vor der Wunde ekelt.

Ziele:

- Der aktuelle Wundzustand wird korrekt eingeschätzt.
- Die Lebensqualität des Bewohners bleibt soweit möglich erhalten.
- Der Bewohner ist über sein Krankheitsbild informiert. Er weiß, dass chronische Wunden eine erhebliche Gefährdung seiner Gesundheit darstellen. Er ist dazu motiviert, sein Verhalten und seine Konsumgewohnheiten so weit zu ändern, dass die Ausheilung der Wunde gefördert wird.
- Die Schmerzbelastung des Pflegebedürftigen wird minimiert.
- Komplikationen werden verhindert, insbesondere eine Wundinfektion.
- Wir erreichen einen vollständigen Wundverschluss. Im Idealfall kann auch die Bildung von übermäßigem Narbengewebe verhindert werden. Das Selbstbild des Pflegebedürftigen bleibt gewahrt.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	1	Verw./MA

- Ein Rezidiv wird verhindert. Dazu zählt auch ein erneutes Auftreten der Wunde an einer leicht veränderten Position.

Vorbereitung:

Beratung

- Wir beraten den Bewohner zu seinem Krankheitsbild. Er kann der Durchführung einzelner Pflegemaßnahmen widersprechen.
- Der Betroffene wird über die Wichtigkeit einer fotografischen Wunddokumentation informiert. Er wird um Zustimmung für die Bilderstellung gebeten.
- Wir beraten den Bewohner zum richtigen Verhalten bei bereits bestehenden Wunden. Er soll den Verband nicht selbstständig abnehmen. Überdies ist es zu vermeiden, sich in der Wundumgebung an der Haut zu kratzen.
- Basierend auf den verfügbaren Informationen erstellen wir gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen einen Behandlungsplan. Wenn sich der Bewohner wichtigen Maßnahmen zur Wundheilung widersetzt, wirken wir beständig auf ihn ein. Wir verdeutlichen ihm die Bedeutung der Wundheilung für seine Gesunderhaltung.

Allgemeines Verfahren im Haus

- Interner Wundexperte wird hinzu gezogen
- Ext. Wundexperte wird hinzu gezogen,
 - diese kommt ca. alle 2 Wochen und bei Bedarf ins Haus
 - sie erhebt die Ausmessung der Wunde und ist für Fotodokumentation verantwortlich
 - sie lässt uns Wundbericht zukommen
- wird keine Wundschwester vom HA gewünscht erfolgt die Wundausmessung und Fotodokumentation durch unsere Fachkräfte alle 2 Wochen oder bei Verschlechterung der Wunde bis zur Abheilung
- Für jede Wunde wird eine Wunddokumentation angelegt
- die Dokumentation des Verbandswchsel erfolgt auf Durchführungsnachweis
- dies wird vollständig und fortlaufend ausgefüllt
- sollte ein Verband außerhalb des normalen Intervalls erneuert werden müssen, wird dies im Berichtblatt eingetragen und begründet und dann erfolgt noch eine normale Wunddokumentation
- bei tgl. Verbandswchsel reicht eine Wundbeschreibung Mo / Mi/ Fr

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	2	Verw./MA

Wie ist eine Fotodokumentation durchzuführen?

- Es wird immer der selber Fotoapparat verwendet (jedes Team hat einen)
- Es muss immer der selbe Abstand zur Wunde eingehalten werden(Länge der Schnurr des Apparates)
- Der Patient sollte immer in die gleiche Position gebracht werden

Organisation

- Eine Pflegekraft wird zur Wundbeauftragten weitergebildet. Alternativ dazu etablieren wir eine Kooperation mit einem externen Wundmanager.
 - Firma
 - Name
 - Mobil:
 - E-Mail:
- Wir stellen sicher, dass der Patient von einem Hausarzt versorgt wird. Wichtig ist auch die Bereitschaft, die notwendigen Wundaufgaben zu verschreiben, wenn der Zustand des Patienten dieses erfordert.
- Wir kooperieren auch eng mit den anderen Berufsgruppen, insbesondere mit Physiotherapeuten, mit Podologen
- Die Maßnahmen im Rahmen der Wundbehandlung sind Bestandteil der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
- Wir nutzen die Mitarbeitervisite, um Wissensdefizite unserer Mitarbeiter zeitnah zu erkennen und aufzuarbeiten.

Informationssammlung

- Die Größe der Wunde wird regelmäßig ermittelt.
- Wir nutzen die Wundfotografie, um den Entwicklungsverlauf eines Gewebedefekts abbilden zu können.
- Der Infektionsstatus der Wunde wird regelmäßig überprüft. Falls notwendig erfolgt ein Wundabstrich, um eine etwaige Keimbesiedelung einschätzen zu können.
- Im Rahmen der regelmäßigen Pflegevisiten erfragen wir, wie sehr die Lebensqualität des Pflegebedürftigen durch die chronische Wunde eingeschränkt wird.

Allgemeine Förderung der Wundheilung

- Wir stellen sicher, dass der Patient ausreichend Nährstoffe zu sich nimmt. Vor allem eine angemessene Protein- und Aminosäurenversorgung ist wichtig, damit der Körper ausreichend Binde- und Granulationsgewebe bilden kann.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	3	Verw./MA

- Im Rahmen des Möglichen werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen therapiert, vor allem eine Herzinsuffizienz.
- Die schädlichen Auswirkungen von Stoffwechselstörungen wie etwa Diabetes mellitus werden minimiert.
- Bei allen Tätigkeiten an der Wunde ist eine strikt keimfreie Vorgehensweise unverzichtbar. Dazu zählen etwa die Händehygiene, die Nutzung von Einmalhandschuhen sowie die bevorzugte Verwendung von Non-Touch-Techniken.
- Wir nutzen Wundspülungen, um Wundsekret, Gewebetrümmer oder nekrotisches Gewebe aus dem Wundgebiet zu entfernen.
- Chronische Wunden können zu einem erheblichen Juckreiz führen. Durch das Kratzen kann die Wunde jedoch verunreinigt werden. Daher versuchen wir, den Juckreiz zu lindern und den Patienten davon abzulenken.
- Wunden müssen beim Waschen vor dem Kontakt mit dem Waschwasser geschützt werden. Viele Betroffene benötigen daher Hilfe bei der Körperpflege. Wir assistieren ggf. dem Patienten bei der Ganzwaschung.
- Duschen und Bäder sind bei offenen Wunden nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt möglich. Ggf. wird die Wunde Wasser abweisend abgedeckt.
- Alkoholgenuss und rauchen behindert die Wundheilung. Der Pflegebedürftige sollte beides reduzieren oder im Idealfall einstellen.

Weitere Maßnahmen

- Bei stark nässenden Wunden erfolgt ein täglicher Wechsel der Bettwäsche. Wir vermeiden damit, dass der Geruch in die Bettwäsche übergeht.
- Insbesondere bei Hautdefekten mit sehr negativer Prognose ist es wichtig, die eigentliche Wundversorgung um Elemente der psychologischen Betreuung zu erweitern.
- Bei der Wundversorgung achten wir nicht nur auf den eigentlichen Hautdefekt, sondern auch auf die Wundumgebung. Vor allem eine Mazeration sollte vermieden werden.
- Wunden sind zumeist mit einer erheblichen Schmerzbelastung verbunden. Wir stellen daher sicher, dass der Pflegebedürftige eine angemessene Analgetikatherapie erhält.
- Im Umgang mit verwirrten Senioren ist jedoch häufig keine hinreichende Kommunikation mehr möglich. Durch eine genaue Beobachtung von Demenzpatienten schätzen wir ein, ob und in welchem Maß diese unter Wundschmerzen leiden.
- Chronische Wunden gelten als Auslöser für Depressionen und für Selbsttötungen. Wir achten daher sehr sorgfältig auf Stimmungseintrübungen und wirken im Rahmen unserer Möglichkeiten stabilisierend auf den Bewohner ein.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	4	Verw./MA

- Wundschmerzen können zur Immobilität führen. Mangelnde Bewegung wiederum steigert das Risiko für viele Komplikationen wie etwa Dekubitus, Kontrakturen oder Pneumonien. Wir intensivieren daher die entsprechenden Prophylaxemaßnahmen. Wichtig ist auch eine umfassende Deprivationsprophylaxe.
- Chronische Wunden können eine Sepsis ('Blutvergiftung') auslösen. Wir achten auf entsprechende Symptome.

Nachbereitung:

- Wenn wir eine Wunde zur Abheilung bringen, versuchen wir immer auch, die Narbenbildung so zu steuern, dass ein kosmetisch ansprechendes Gesamtbild entsteht.
- Falls es als Folge von Komplikationen zu Teilamputationen oder zu einer Defektheilung gekommen ist, rechnen wir stets mit Körperbildstörungen. Wichtig ist dann vor allem eine intensivisierte zwischenmenschliche Betreuung.
- Alle Beobachtungen und Pflegemaßnahmen werden sorgfältig dokumentiert.
- Die Pflege- und Maßnahmenplanung wird an die sich verändernden Pflegeprobleme und Ressourcen angepasst.

Dokumente:

- Wunddokumentation
- Einverständniserklärung zur Fotodokumentation
- ärztliches Verordnungsblatt
- Wundbericht ext. Wundschwester
- Kommunikationsblatt mit dem Arzt

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	5	Verw./MA